Pancreatitis aguda

SEMIOLOGIA · Clase 29 · autodigestión, dolor en barra, Cullen y Grey Turner

1 · QUÉ ES: EL PÁNCREAS SE DIGIERE A SÍ MISMO

Pancreatitis aguda F1
inflamación por autodigestión enzimática; no es local sino sistémica

se explica por la

Activación de las enzimas propias F1
dentro del páncreas, que lesionan la glándula

2 · POR QUÉ SE PRODUCE: CÁLCULOS Y ALCOHOL

Metabólicas F2
hipertrigliceridemia, hipercalcemia

Fármacos F2
corticoides, estrógenos, clorotiazida

Cálculos biliares F2
obstruyen la papila y hacen refluir bilis; más frecuentes en mujeres

Alcoholismo F2
segunda etiología principal; más frecuente en varones

con menos frecuencia causan

Otras causas menores F2
trauma, parotiditis, genética y tumor ampular

con menos frecuencia causan
al obstruir la papila causa la
con menos frecuencia causan
es la segunda causa de
según cuánto destruye adopta
si afecta la cabeza
o el alcohol elevan

3 · CUATRO FORMAS DE GRAVEDAD CRECIENTE

Formas fisiopatológicas F13
cuatro, de gravedad creciente

si solo hay edema

Edematosa
simple: escasa infiltración y edema

si sangra el parénquima

Hemorrágica
destrucción del parénquima con hemorragia; mal pronóstico

si además hay isquemia

Necrohemorrágica
isquemia y necrosis; la más grave

si se sobreinfecta

Supurativa
infección secundaria

la infección obliga a medir la

libera

libera

Exudado hemorrágico F7 · F8
se extravasa hacia la pared y el retroperitoneo

alrededor del ombligo da el

en los flancos da el

Signo de Cullen F6 · F7 · F9
equimosis periumbilical; signo tardío (el banco lo atribuye también al ectópico roto)

Signo de Grey Turner F8 · F9
equimosis en los flancos; signo tardío (el banco lo atribuye al ectópico roto)

por eso

por eso

Las equimosis tardías señalan pancreatitis hemorrágica o necrohemorrágica grave

4 · CÓMO SE PRESENTA

Edema de la cabeza pancreática
comprime el colédoco terminal

por eso aparece

Ictericia
en el 20% según 2020

se aclara al
su gravedad se mide con el
se aclara al
se presenta con

Dolor F3 · F4
epigástrico súbito, lancinante, en barra hacia el dorso

en literatura, la presión revela

se acompaña de

el intestino se paraliza:

Íleo localizado
ruidos disminuidos o ausentes; abdomen flácido y distendido; 60% sin gases ni heces

Vómitos incoercibles
con sudor

y en el examen general

Repercusión general
fiebre 37,5-38,5 °C, hipotensión o shock

Puntos pancreáticos F5
Desjardins (5-7 cm sobre el ombligo, línea ombligo-axila derecha), Chauffard y Mayo-Robson; tu docente no los describe

puede progresar al

5 · ENZIMAS Y LABORATORIO: ÚTILES PERO NO ESPECÍFICOS

Fosfatasa alcalina y bilirrubina
se elevan si hay alcohol o coledocolitiasis

Calcio sérico F13
rango normal 2020: 6-11 mg/dL; menor de 7 mg/dL = mal pronóstico

cálculos y colédoco en la
contribuye a
el laboratorio general muestra

Hemograma, glicemia y hemoconcentración F12 · F13
leucocitosis con desviación izquierda, hiperglicemia; hematocrito y BUN altos miden gravedad

se completa con

si baja de 7 mg/dL
se estudia con la
contribuye a

Gases
disturbio ácido-base

contribuye a

Amilasa F10 · F11 · F12
suele triplicar lo normal y se normaliza en 36-72 h

cuando ya bajó, persiste la

su derrame se ve en la

pero

No es específica F13
la misma elevación aparece en otros cuadros

Lipasa F12
permanece elevada más tiempo

porque también sube en

por eso hay que

También elevan la amilasa
úlcera perforada, colecistitis, obstrucción intestinal, trombosis mesentérica, IRA y ectópico roto

6 · IMÁGENES Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

el cálculo ductal se ve en la

Rx de abdomen F12
cálculo ductal

Rx de tórax F12
atelectasia o derrame

junto a las demás imágenes

junto a las demás imágenes

La enzima aislada no basta: integrar clínica, laboratorio e imágenes

la forma se tipifica con la

Ecografía F12
cálculos, colédoco y edema pancreático

TAC F12 · F13
la de mayor utilidad: define el tipo y la gravedad

ayuda a excluir

ayuda a excluir

Diferenciales
úlcera perforada, colecistitis, coledocolitiasis, infarto mesentérico, diverticulitis, obstrucción y absceso pancreático

7 · GRAVEDAD Y COMPLICACIONES MAYORES

Pseudoquiste pancreático F1
amilasa persistentemente elevada

Shock F1
secundario a derrame pleural, insuficiencia renal o respiratoria

obliga a

obliga a

si no se normaliza sugiere

Calcio bajo o complicaciones exigen manejo de pancreatitis grave

síndrome · mecanismo · causa · concepto · signo · desenlace · síntoma · diagnóstico · ejemplo · complicación · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Clase 09d · Dr. Sotomayor, Semiología 2020 y Sotito 2018 — teoría del docente (= literatura)